RINGKASAN KEBIJAKAN FORMULARIUM

Komite Farmasi dan Terapi (KFT)

ID Kasus	DB_DEMO_HF_001
Judul	Demo ARNI vs Ramipril pada HFrEF
Intervensi	Sacubitril/valsartan (ARNI)
Komparator	Ramipril (ACEI)
Indikasi	Heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF)
Populasi target	Dewasa ≥18 tahun, HFrEF LVEF ≤40%, NYHA II–IV, stabil
Setting	Formularium rumah sakit; rawat jalan HFrEF
Perspektif	Rumah Sakit
Status saat ini	Disetujui
Versi dokumen	v1
Tanggal terbit	27 Oktober 2026

1. Ringkasan Eksekutif

Keputusan Final KFT

Adopsi dengan kriteria akses (Adopt with criteria-based access)

Alasan: Manfaat klinis dan cost-effectiveness deterministik mendukung, tetapi hasil PSA tidak pasti dan dampak anggaran meningkat. Adopsi dibatasi pada pasien yang memenuhi kriteria akses.

Dicatat oleh dr. Indah Permata, Sp.JP, 27 Oktober 2026, 17:20 WIB.

Rekomendasi Sistem

Warna dan skor berikut dihitung otomatis oleh sistem sebagai bahan pertimbangan. Keputusan di atas adalah keputusan KFT.

KUNING — ADOPSI BERSYARAT (CBA)

Komponen	Nilai
Skor Komposit	69.44 / 100
Bukti EtD (bobot 40%)	73.61
Cost-effectiveness (bobot 30%)	100.00
Dampak Anggaran (bobot 20%)	50.00
Kriteria CBA (bobot 10%)	0.00
Algoritma	2.0.0
Waktu komputasi	27 Oktober 2026, 17:20 WIB

Justifikasi:

Skor komposit: 69.44 / 100. Bukti EtD: 73.61 (bobot 40%). CEA: 100 (bobot 30%). Anggaran (BIA): 50 (bobot 20%). Tidak ada dari 4 kriteria CBA terpenuhi (skor 0, bobot 10%). REKOMENDASI: KUNING — adopsi bersyarat.

2. Pertanyaan Keputusan dan Populasi Target

Populasi target: Dewasa ≥18 tahun, HFrEF LVEF ≤40%, NYHA II–IV, stabil

Q1: Apakah ARNI diadopsi dibanding ramipril untuk pasien HFrEF eligible?

Unsur PICO	Isi
Populasi (P)	Dewasa ≥18 tahun, HFrEF LVEF ≤40%, NYHA II–IV, stabil
Intervensi (I)	Sacubitril/valsartan (ARNI)
Komparator (C)	Ramipril (ACEI)
Outcome (O)	QALY; rehospitalisasi HF

3. Analisis Efektivitas Biaya (CEA)

Komponen	Nilai
ICER	Rp 225.454.545 per unit efektivitas
Klasifikasi dominansi	Cost-effective pada WTP terpilih
Biaya intervensi	Rp 16.500.000
Biaya komparator	Rp 4.100.000
Efektivitas intervensi (QALY)	0.7500
Efektivitas komparator (QALY)	0.6950
Ambang WTOP	Rp 300.000.000 / QALY
Skor CE	100.00 / 100

4. Analisis Dampak Anggaran (BIA)

Periode	Pasien	Dampak Biaya	% Anggaran
Tahun 1	40	Rp 496.000.000	2.48%
Tahun 2	77	Rp 954.800.000	4.77%
Tahun 3	120	Rp 1.488.000.000	7.44%
Kumulatif	—	Rp 2.938.800.000	4.90%

Klasifikasi severity: Signifikan

5. Analisis Sensitivitas Probabilistik (PSA)

Komponen	Nilai
Jumlah iterasi	5.000
Seed acak	42
WTP dasar	Rp 300.000.000 / QALY
Peluang cost-effective pada WTP dasar	56.0%
Rerata selisih biaya	Rp 12.414.195
Rerata selisih QALY	0.0540
Selisih biaya base case	Rp 12.400.000
Selisih QALY base case	0.0550
Waktu komputasi	27 Oktober 2026, 17:19 WIB

Kurva penerimaan biaya-efektivitas (CEAC):

WTP per QALY	Peluang cost-effective
Rp 0	0.0%
Rp 150.000.000	37.4%
Rp 300.000.000	56.0%
Rp 450.000.000	61.7%
Rp 600.000.000	64.9%

PSA 5000 iterasi (seed 42). Probabilitas cost-effective pada WTP 300,000,000 IDR = 56.0%. Rata-rata incremental cost 12,414,195 IDR, incremental QALY 0.0540.

6. Evidence-to-Decision (EtD) — 9 Domain GRADE

Domain	Skor rata-rata	Judgement	Certainty dominan	Voter
Masalah (Problem)	100.00	Ya	Sedang	1
Efek yang Diinginkan	75.00	Mungkin ya	Sedang	1
Efek yang Tidak Diinginkan	75.00	Mungkin ya	Sedang	1
Kepastian Bukti	75.00	Mungkin ya	Sedang	1
Nilai & Preferensi	75.00	Mungkin ya	Sedang	1
Penggunaan Sumber Daya	50.00	Tidak pasti	Sedang	1
Ekuitas	50.00	Tidak pasti	Sedang	1
Kelayakan Implementasi	75.00	Mungkin ya	Sedang	1
Penerimaan oleh Pemangku Kepentingan	75.00	Mungkin ya	Sedang	1

Domain terisi: 9 / 9 · Skor kekuatan bukti agregat: 73.61 / 100

7. Kriteria Akses (CBA)

Kriteria	Operator	Nilai	Terpenuhi	Catatan
Eligibilitas: HFrEF terkonfirmasi	Ada / Terdapat	—	Belum	Diagnosis HFrEF dikonfirmasi (LVEF ≤40%, NYHA II–IV); memenuhi kriteria klinis lokal.
Prescriber: inisiasi oleh spesialis	Ada / Terdapat	—	Belum	Inisiasi oleh spesialis terkait.
Monitoring: tekanan darah, fungsi ginjal, K+	Ada / Terdapat	—	Belum	Tekanan darah, fungsi ginjal dan kalium dimonitor; review tolerabilitas.
Stop/ reassess	Ada / Terdapat	—	Belum	Reassess bila intoleransi/m

				asalah keselamatan atau tidak lagi memenuhi kriteria.

Status keseluruhan: 0 / 4 kriteria terpenuhi · Skor CBA: 0.00 / 100

8. Daftar Referensi

1. [1] (2026). SRC-DEMO-01 Farmasi demo (sintetis, 2026)
2. [2] (2026). SRC-DEMO-02 RWE demo (sintetis, 2026)
3. [3] (2026). SRC-DEMO-03 Billing demo (sintetis, 2026)
4. [4] (2026). SRC-DEMO-04 Utility demo (sintetis, 2026)
5. [5] (2026). SRC-DEMO-05 SIMRS demo (sintetis, 2026)
6. [6] (2026). SRC-DEMO-06 Protokol latihan (asumsi, 2026)

9. Ringkasan Audit & Tanda Tangan

Waktu	Keputusan	Penandatangan	Alasan	IP
27 Oktober 2026, 17:20 WIB	Disetujui	Dr. Bambang Sutrisno, Sp.JP <ketua@test.local>	—	172.18.0.xxx

Dokumen ini diterbitkan oleh sistem DeciBridge dan tercatat dalam audit log yang bersifat append-only. Setiap perubahan setelah penerbitan akan tercatat sebagai versi baru dengan hash SHA-256 berbeda.